

TURP — Résection transurétrale de la prostate (RTUP/TURP)

Information pour le patient · L'intervention chirurgicale de référence pour la prostate hypertrophiée

WARWIKI

La TURP est une chirurgie courante et bien éprouvée pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) qui bloque l'écoulement des urines. À l'aide d'un endoscope introduit par l'urètre — **sans incision externe** — le chirurgien résèque le tissu prostatique intérieur qui comprime le canal urinaire. Ce geste améliore le débit de façon durable et bénéficie de plusieurs décennies de recul.

À propos de cette intervention

Un instrument fin (le **résectoscope**) est introduit par l'urètre. À l'aide d'une petite anse électrique, le chirurgien retire morceau par morceau le tissu prostatique obstructif, élargissant ainsi le canal. La partie externe de la prostate est laissée en place. Une sonde est ensuite posée le temps que la zone cicatrise.

Est-ce sans danger ?

La TURP est l'une des opérations urologiques les plus étudiées et elle est très efficace. Comme toute chirurgie, elle comporte des risques — saignement, infection, irritation transitoire — ainsi que certains effets durables attendus (voir ci-dessous). Elle convient particulièrement aux prostates de **taille modérée** ; les glandes très volumineuses peuvent bénéficier davantage d'une HoLEP, d'une Aquablation ou d'une prostatectomie simple.

COMPRENDRE LES TERMES

TURP

Résection transurétrale de la prostate — chirurgie endoscopique pour la HBP.

HBP

Hypertrophie bénigne (non cancéreuse) de la prostate.

Résectoscope

L'endoscope muni d'une anse utilisé pour réséquer la prostate.

Éjaculation rétrograde

Le sperme repart en arrière dans la vessie — effet secondaire courant et sans danger.

Sonde

Tube drainant la vessie pendant 1 à 3 jours après l'opération.

Irrigation vésicale

Rinçage doux par la sonde pour évacuer le sang dans les premiers jours.

QU'EST-CE QUI CHANGE APRÈS L'OPÉRATION ? La plupart des hommes retrouvent un jet nettement plus fort. Le changement durable le plus fréquent est l'**éjaculation rétrograde** — le sperme repart dans la vessie ; l'orgasme est normal mais avec peu ou pas de liquide. Cela est sans danger (bien que cela affecte la fertilité). Les effets graves sur les érections ou le contrôle des urines sont rares.

Comment vous préparer

- Réalisée sous **anesthésie rachidienne ou générale** — respectez les consignes de jeûne et de médicaments (suspendez les anticoagulants selon les instructions).
- Un **examen d'urine** pour écarter une infection au préalable.
- Prévoyez un accompagnateur et planifiez la présence d'une sonde pendant quelques jours.

Déroulement & Après

- 1 Vous êtes endormi(e) ou insensibilisé(e) ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Le tissu prostatique obstructif est réséqué par endoscope.
- 3 Une sonde est mise en place, parfois avec un rinçage vésical doux le premier jour.
- 4 Généralement une nuit en hospitalisation ; sonde retirée en **1 à 3 jours**.

Attendez-vous à des **urines teintées de sang** et à des brûlures ou urgences mictionnelles pendant quelques semaines ; buvez suffisamment et évitez les efforts et le port de charges lourdes.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Impossibilité d'**uriner** après le retrait de la sonde
- **Saignement abondant ou caillots** bloquant l'écoulement
- De la fièvre ou des frissons
- Un saignement qui s'aggrave (un léger saignement vers 1 à 2 semaines est fréquent — repos et hydratation)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La TURP retire le tissu prostatique obstructif par endoscope (sans incision) — la référence durable et très efficace pour la HBP modérée.
2. Attendez-vous à un jet plus fort ; le changement durable le plus courant est une éjaculation sèche ou rétrograde (sans danger).
3. Les urines teintées de sang et l'irritation disparaissent en quelques semaines. Consultez en cas d'impossibilité d'uriner, de saignement abondant ou de fièvre.